Antihypertenseurs

Objectif selon le profil, stratégie pas à pas, sujet âgé, puis classes → molécules → noms commerciaux.
EHPAD · FAM · EAM · MAS · IME — médecins DOTR, médecins coordonnateurs

FICHE PRATIQUE DOTR
MÉDICAMENTS & SÉCURITÉ
Mise à jour : Octobre 2026

À RETENIR

Confirmer l'HTA hors cabinet (automesure ≥ 135/85) avant de traiter. IEC ou ARA2, inhibiteur calcique, thiazidique en 1re intention, puis bithérapie, puis trithérapie. Sujet âgé : PAS < 150 sans hypotension orthostatique, 3 molécules maximum, ne pas descendre trop bas.

Sources : HAS 2016 · ESC 2024

1 · Objectif tensionnel

Profil	Objectif (cabinet / automesure)	À ne pas dépasser vers le bas
Adulte < 80 ans	**PAS 130–139, PAD < 90** automesure < 135/85 ; 120–129 si toléré (ESC)	Ne pas viser < 120/70 (ESH)
≥ 80 ans autonome	**PAS < 150** automesure < 145 ; ESH : 140–150	Sans hypotension orthostatique ; 3 molécules max (HAS)
Fragile, dépendant (EHPAD, MAS)	**PAS < 150** objectif individualisé	Réduire si PAS < 130 sous ≥ 2 traitements, chutes, hypotension orthostatique

Sources : HAS 2016 · ESC 2024 · ESH 2023

2 · Stratégie

① DÉBUTER

- **HAS** : monothérapie **IEC ou ARA2, inhibiteur calcique ou thiazidique**, réévaluée à **1 mois**.
- **ESC** : bithérapie d'emblée en comprimé unique chez la plupart des patients.
- **≥ 80 ans, fragile** : monothérapie faible dose (Ica dihydropyridine ou IEC/ARA2), titration lente.
- Bêtabloquant : 2e choix, sauf indication propre (IC, post-IDM, angor, FA).

Sources : HAS 2016 · ESC 2024

② INTENSIFIER

- Objectif non atteint à 1 mois : **bithérapie** (2 classes parmi IEC/ARA2, Ica, thiazidique), plutôt qu'augmenter la dose.
- Puis **trithérapie IEC/ARA2 + Ica + thiazidique** à dose optimale (Triplixam).
- DFG < 30 : diurétique de l'anse à la place du thiazidique.
- Objectif en 6 mois (HAS) ; consultation mensuelle jusque-là.

Sources : HAS 2016 · ESC 2024

③ HTA RÉSISTANTE

- Vérifier observance, automesure, sel, alcool, AINS, corticoïdes, apnées du sommeil ; avis spécialisé.
- **Spironolactone 12,5–50 mg/j** : avant 80 ans, DFG ≥ 30 (ESC : K+ ≤ 4,5) ; K+ et créatinine à 1 et 4 semaines.
- À défaut : bêtabloquant, puis alpha-bloquant ou central sur avis.

Sources : HAS 2016 · SFHTA · ESC 2024

CHOIX SELON LE TERRAIN

- **Diabète, MRC, albuminurie** : IEC ou ARA2.
- **Insuffisance cardiaque** : IEC (ou ARA2), bêtabloquant ayant l'AMM, diurétique ; **jamais vérapamil ni diltiazem**.
- **Post-IDM, angor** : bêtabloquant + IEC/ARA2.
- **Post-AVC** : IEC/ARA2 + Ica ou thiazidique.
- Goutte, troubles mictionnels, hypotension orthostatique : éviter le thiazidique.

Sources : HAS 2016 · ESC 2024

ASSOCIATIONS À ÉVITER

- **IEC + ARA2** (double blocage) : non recommandée.
- **Bêtabloquant + vérapamil ou diltiazem** : déconseillée (bradycardie, blocs).
- IEC/ARA2 + potassium ou amiloride : déconseillée sauf hypokaliémie.
- IEC/ARA2/diurétique + **AINS** : insuffisance rénale aiguë chez le sujet âgé.

Sources : ANSM · ESC 2024

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

- Avant : Na, K, créatinine (DFG), glycémie, lipides, protéinurie, ECG.
- IEC, ARA2, diurétique : **Na, K, créatinine 1 à 4 semaines** après le début et à chaque changement.
- Thiazidique : natrémie régulière, plus souvent chez le sujet âgé.
- Ensuite tous les 1 à 2 ans, plus souvent si diabète, IRC, âge.

Sources : HAS 2016 · RCP · BDPM 14/10/2026

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. HAS 2016 (référence française), ESC 2024 et ESH 2023 (européennes) ; ne remplace ni le RCP ni l'avis spécialisé. Outil interactif sur l'Espace VMS / DOTR.

SUJET ÂGÉ EN ESMS

- Rechercher l'**hypotension orthostatique** (couché puis debout à 1 et 3 min) avant de débuter ou d'intensifier, et après une chute.
- Éviter centraux et alpha-bloquants (chutes) ; **Loxen 20 mg** (nicardipine immédiate) inapproprié après 75 ans.
- Diarrhée, fièvre, déshydratation : suspension temporaire possible des IEC/ARA2/diurétiques (HAS), au cas par cas (ANSM), **avec un plan de reprise écrit**.

Sources : HAS 2016 · ESC 2024 · Laroche 2007 · ANSM

PA TRÈS ÉLEVÉE

- **PA ≥ 180/110 avec atteinte d'organe** (douleur thoracique, dyspnée, déficit, confusion, troubles visuels) : **15**.
- Sans atteinte d'organe : pas de baisse rapide ; traiter douleur et anxiété, traitement oral habituel, réévaluer rapidement.
- **Jamais** de nifédipine ou nicardipine à libération immédiate pour « faire baisser ».

Sources : ESC 2024 · Laroche 2007

3 · Classes → molécules → noms commerciaux (voie orale, commercialisés)

IEC — 1re intention

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
bénazépril	génériques	10 mg (2,5 mg si diurétique ou HTA rénovasculaire) → non précisé en 4.2 (posologie efficace 10 mg/j)	ClCr ≥30 : inchangé ; <30 : 5 mg/j	65 %
captopril	Noyada + gén.	25 mg x2/j (12,5 mg si diurétique ; 6,25 mg si HTA rénovasculaire) → 150 mg/j (exceptionnellement plus)	ClCr >40 : max 150 mg (init 25-50) ; 21-40 : max 100 (init 25) ; 11-20 : max 75 (init 12,5) ; ≤10 : max 37,5 (init 6,25) ; dialysable	65 %
énalapril	Renitec + gén.	5-10 mg (≤5 mg si SRAA stimulé/diurétique) → 40 mg/j (entretien usuel 20 mg)	ClCr >30 : init 5-10 ; 10-30 : 2,5 mg ; ≤10 : 2,5 mg les jours de dialyse	65 %
fosinopril	génériques	10 mg (5 mg si diurétique ou HTA rénovasculaire) → 20 mg/j	Pas d'adaptation même ClCr <30 ; peu dialysable	65 %
lisinopril	Zestril + gén.	10 mg (2,5-5 mg si SRAA stimulé ; 5 mg si diurétique non arrêté) → 80 mg/j (max études) ; entretien usuel 20 mg	ClCr 31-80 : init 5-10 ; 10-30 : 2,5-5 ; <10/dialyse : 2,5 ; max 40 mg/j en IR	65 %
périndopril	Coversyl + gén.	5 mg (arginine) le matin ; 2,5 mg si SRAA stimulé/diurétique → 10 mg/j (arginine)	ClCr ≥60 : 5 mg ; 30-60 : 2,5 mg ; 15-30 : 2,5 mg 1 j/2 ; <15 dialysé : 2,5 mg jours de dialyse	65 % / non remboursé
ramipril	Triatec + gén.	2,5 mg (1,25 mg si SRAA stimulé ou diurétique) → 10 mg/j	ClCr ≥60 : max 10 ; 30-60 : max 5 ; 10-30 : init 1,25, max 5 ; hémodialyse : init 1,25, max 5	65 %
trandolapril	Odrik + gén.	2 mg (0,5 mg si diurétique ou HTA rénovasculaire) → 4 mg/j	ClCr >30 : inchangé ; 10-30 : init 0,5, max 1 mg ; <10 : 0,5 mg ; dialysable	65 %
zofénopril	Zofenil + gén.	15 mg (7,5 mg si déplétion non corrigeable) → 60 mg/j (usuel 30 mg)	ClCr >45 : inchangé ; <45 : moitié de dose ; dialyse : quart de dose	65 %

ARA2 (sartans) — 1re intention

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
candésartan	Atacand, Kenzen + gén.	8 mg (4 mg si déplétion volémique) → 32 mg/j	Init 4 mg (y compris hémodialysés) ; expérience limitée si ClCr <15	65 %
irbésartan	Aprovel, Ifirmasta + gén.	150 mg (75 mg si hémodialyse ou >75 ans) → 300 mg/j	Pas d'adaptation ; hémodialyse : init 75 mg	65 %
losartan	Cozaar + gén.	50 mg (25 mg si hypovolémie) → 100 mg/j	Pas d'adaptation (y compris hémodialyse)	65 %
olmésartan	Alteis, Olmetec	10 mg → 40 mg/j	ClCr 20-60 : max 20 mg ; <20 : déconseillé	non remboursé
telmisartan	Micardis + gén.	40 mg (20 mg peut suffire) → 80 mg/j	IR légère-modérée : inchangé ; IR sévère/hémodialyse : init 20 mg	65 %
valsartan	Tareg + gén.	80 mg → 320 mg/j	Pas d'adaptation si ClCr >10 ml/min	65 %

Inhibiteurs calciques dihydropyridines — 1re intention

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
amlodipine	Amlor + gén.	5 mg → 10 mg/j	Posologie usuelle	65 %
félodipine LP	Flodil LP + gén.	5 mg (2,5 mg possible) → 10 mg/j	Pas d'adaptation	65 %
isradipine LP	Icaz LP	5 mg (2,5 mg si âgé, IR, IH) → non précisé en 4.2	Init 2,5 mg	65 %
lercanidipine	Zanidip + gén.	10 mg (5 mg possible) ≥15 min avant petit-déjeuner → 20 mg/j	IR légère-modérée : prudence pour 20 mg ; DFG <30 (dont dialyse) : CI	65 %
manidipine	Iperten + gén.	10 mg (après petit-déjeuner) → 20 mg/j	IR légère-modérée : prudence pour passer à 20 ; ClCr <10 : CI	65 %
nicardipine	Loxen, Loxen LP	LP 50 mg x2/j ; ou 20 mg x3/j → LP : 100 mg/j ; LI : 90 mg/j	non précisé en 4.2	65 %
nifédipine LP	génériques	30 mg → 60 mg/j	non précisé dans l'extrait 4.2 lu (non vérifié)	65 %
nitrendipine	génériques	20 mg (10 mg chez âgé ou IH) → 40 mg/j	Pas d'ajustement	65 %

Diurétiques thiazidiques et apparentés — 1re intention

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
ciclétanine	génériques	50 mg → 150 mg/j (usuel 100 mg)	Ajustement possible (non chiffré)	65 %
hydrochlorothiazide	Esidrex + gén.	12,5 mg → 25 mg/j (au-delà : associer)	IR légère-modérée : inchangé ; ClCr <30 / anurie : CI	65 % / non remboursé
indapamide	Fludex + gén.	1,5 mg LP (ou 2,5 mg LI) → 1,5 mg LP / 2,5 mg LI (doses plus élevées sans gain)	ClCr <30 : CI	65 % / non remboursé

Bêtabloquants — 2e choix (HAS) ; indication propre : IC, post-IDM, angor, FA

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
acébutolol	Sectral, Sectral LP + gén.	400 mg → Majorable si HTA sévère (non chiffré)	non précisé en 4.2	65 % / non remboursé
aténolol	Tenormine + gén.	100 mg (50 mg privilégié en IR) → Non chiffré (« posologie supérieure » si HTA sévère)	ClCr ≥35 : inchangé ; 15-35 : 50 mg/j ; <15 : 25 mg/j ou 50 mg/2 j ; hémodialyse : 50 mg après chaque séance	65 %
bétaxolol	Kerlone + gén.	20 mg → non précisé (usuel 20 mg)	ClCr ≥20 : inchangé ; <20 : init 10 mg/j	65 %
bisoprolol	Detensiel + gén.	10 mg (5 mg chez âgé) → 20 mg/j	IR légère-modérée : inchangé ; ClCr <20 : max 10 mg	65 %
céliprolol	Celectol + gén.	200 mg (à jeun) → 600 mg/j	ClCr 15-40 : surveiller FC ; <15 : non recommandé	65 %
labétalol	Trandate	200 mg x2 (100 mg x2 chez âgé) → non chiffré (400-800 mg/j usuel, plus si sévère ; 3 prises >800)	Prudence si DFG 15-29	65 %
métoprolol	Lopressor, Lopressor LP, Seloken, Seloken LP + gén.	LP 200 mg le matin (peut être réduit à 50 mg) → non chiffré	non précisé en 4.2	65 %
nadolol	Corgard	80 mg → non chiffré pour l'HTA	ClCr >50 : /24 h ; 31-50 : /24-36 h ; 10-30 : /24-48 h ; <10 : /40-60 h	65 %
nébivolol	Nebilox, Temerit + gén.	5 mg (2,5 mg si IR ou >65 ans) → HTA : 5 mg/j (IC : 10 mg)	Init 2,5 mg ; créatininémie ≥250 µmol/l : non recommandé	65 %
pindolol	Visken Quinze, Visken	15 mg → 60 mg/24 h (30 mg/prise)	non précisé en 4.2	65 %
propranolol	génériques	LI : 40 mg x2-3/j ; LP 160 mg/j (80 mg si âgé, IR, IH) → LI : 320 mg/j habituel ; LP : jusqu'à 4 gél/j	Prudence (IR significative, hémodialyse)	65 %
timolol	Timacor	10 mg → 60 mg/j (>20 mg en plusieurs prises)	non précisé en 4.2	65 %

Inhibiteurs calciques non dihydropyridines — angor, contrôle de la fréquence ; jamais avec un bêtabloquant

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
diltiazem LP	Mono Tildiem LP + gén.	200 mg (notamment âgé, IR, IH) → 300 mg/j	Prudence ; init 200 mg	65 %
vérapamil	Isoptine, Isoptine LP + gén.	LP 240 mg le matin (ou 120 mg x2 forme LI) → 360 mg/j (240 + 120)	Prudence, surveillance étroite	65 %

Antialdostérone et épargneurs de potassium — HTA résistante : spironolactone en 4e ligne

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
amiloride	Modamide	HTA : 5-10 mg/j associé à un thiazidique → 20 mg/j (en général ≤10 mg en HTA)	Créatininémie >125 µmol/l ou urée >10 mmol/l : CI sauf contrôles fréquents	65 %
spironolactone	Aldactone + gén.	HTA essentielle : 50 mg → 100 mg/j (paliers 6-8 sem)	IR sévère/aiguë : CI	65 % / non remboursé

Diurétiques de l'anse — remplace le thiazidique si DFG < 30

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
furosémide	Lasilix + gén.	HTA de l'IRC : 20 mg/j → 120 mg/j (HTA de l'IRC)	Indication HTA = IRC	65 % / non remboursé

Alpha-bloquants — dernière ligne ; hypotension orthostatique

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
urapidil LP	Eupressyl LP, Mediatensyl LP + gén.	60 mg/j (2 prises) ; usuel 120 mg → 180 mg/j	IR modérée à sévère : diminution envisageable	65 % / non remboursé

Antihypertenseurs centraux — dernière ligne ; inappropriés après 75 ans (Laroche)

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
clonidine	Catapressan	0,15 mg le soir → Entretien 0,15-0,60 mg/j (jusqu'à 6-7 cp possible)	Adapter (variabilité), surveillance étroite ; peu dialysable	65 %
méthyldopa	Aldomet	250 mg x2-3/j (48 h) → 3 g/j (usuel 0,75-1,5 g)	non précisé en 4.2	65 %
moxonidine	Physiotens + gén.	0,2 mg le matin → 0,6 mg/j (0,4 mg/prise)	DFG 30-60 : init 0,2, max 0,4 ; 15-30 : init 0,2, max 0,3 ; hémodialyse : 0,2 (max 0,4)	65 %
rilménidine	Hyperium + gén.	1 mg le matin → 2 mg/j	ClCr >15 : inchangé ; <15 : CI	30 % / non remboursé

Vasodilatateur direct — HTA sévère résistante, avis spécialisé

Molécule	Spécialités	Début → max	Rein	Remb.
minoxidil	Lonoten	5 mg/j (après ajustement diurétique + BB) → 100 mg/j	Réduction possible (IR, dialyse)	65 %

4 · Associations fixes commercialisées

Type	Spécialités (composants)
IEC ou ARA2 + inhibiteur calcique	APREXEVO (amlodipine + irbesartan); AXELER, SEVIKAR (amlodipine + olmesartan); COVERAM (amlodipine + perindopril); PREMINOR (amlodipine + ramipril); TWYNSTA (amlodipine + telmisartan); EXFORGE (amlodipine + valsartan); LERCAPRESS, ZANEXTRA (enalapril + lercanidipine)
IEC ou ARA2 + diurétique thiazidique	CIBADREX (benazepril + hydrochlorothiazide); COKENZEN, HYTACAND (candesartan + hydrochlorothiazide); génériques (captopril + hydrochlorothiazide); CO-RENITEC (enalapril + hydrochlorothiazide); génériques (fosinopril + hydrochlorothiazide); COAPROVEL, IFIRMACOMBI (hydrochlorothiazide + irbesartan); ZESTORETIC (hydrochlorothiazide + lisinopril); FORTZAAR, HYZAAR (hydrochlorothiazide + losartan); ALTEISDUO, COOLMETEC (hydrochlorothiazide + olmesartan); génériques (hydrochlorothiazide + quinapril); génériques (hydrochlorothiazide + ramipril); MICARDISPLUS (hydrochlorothiazide + telmisartan); COTAREG (hydrochlorothiazide + valsartan); ZOFENILDUO (hydrochlorothiazide + zofenopril); PRETERAX, PRETERVAL, BIPRETERAX, ARLUNIS, PARATERAX (indapamide + perindopril)
Trithérapie IEC + inhibiteur calcique + diurétique	TRIPLIXAM (amlodipine + indapamide + perindopril)
Inhibiteur calcique + diurétique	NATRIXAM (amlodipine + indapamide)
Avec un bêtabloquant	MODUCREN (amiloride + hydrochlorothiazide + timolol); TENORETIC (atenolol + chlortalidone); génériques (atenolol + nifedipine); LODOZ (bisoprolol + hydrochlorothiazide); COSIMPREL (bisoprolol + perindopril); LOGIMAX (felodipine + metoprolol); CONEBILOX, TEMERITDUO (hydrochlorothiazide + nebivolol)
IEC + vérapamil	TARKA LP (trandolapril + verapamil)
Associations de diurétiques	ALDACTAZINE (altizide + spironolactone); LOGIRENE (amiloride + furosemide); génériques (amiloride + hydrochlorothiazide); PRESTOLE (hydrochlorothiazide + triamterene)

Sources : RCP · BDPM 14/10/2026

Molécules hors indication HTA en France (pour information) : sacubitril/valsartan, éplérénone, carvédilol, bumétanide, doxazosine LP. Non commercialisés : aliskiren, prazosine, hydralazine orale, azilsartan, chlortalidone seule, lacidipine… Doses : RCP de la spécialité de référence ; vérifier le RCP du générique. Sources : HAS, fiche mémo Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte, septembre 2016 ; ESC 2024 Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension (McEvoy, Eur Heart J 2024) ; ESH 2023 Guidelines for the management of arterial hypertension (Mancia, J Hypertens 2023) ; SFHTA, HTA résistante (2013) ; consensus SFHTA/SFGG hypotension orthostatique (2014) ; ANSM, Thésaurus des interactions médicamenteuses (2023) ; vague de chaleur (2017) ; RCP des spécialités (BDPM / EMA) ; base de données publique des médicaments, 14/10/2026 ; Laroche ML et al., médicaments potentiellement inappropriés après 75 ans, 2007.